

Le Psicosi

Salute Mentale · Sessione 09 · 22.04.2026

Questa lezione è una vera e propria mappa di un territorio enorme: il mondo delle psicosi. Dal delirium tremens alla schizofrenia, dalla demenza alla crisi pantoclastica — tutto fa parte dello stesso universo. L'obiettivo è orientarsi in questo "universo delle psicosi" capendo come funziona, come si riconosce, e cosa significa per chi lo abita dall'interno.

Che cos'è la psicosi

La psicosi non è una singola malattia ma un **gruppo eterogeneo di disturbi** che condividono una caratteristica fondamentale: un rapporto radicalmente alterato con la realtà.

Eveline Pewzner (2002) lo dice bene:

"Ciò che caratterizza la psicosi non è l'assenza di sofferenza, ma una radicale alterazione del rapporto che il soggetto instaura con la realtà, credendo con forza in un mondo che non è più il mondo esterno al quale noi tutti possiamo fare riferimento, ma un mondo delirante."

Per Giovanni Jervis (1984) ci sono due destrutturazioni centrali: quella della realtà esterna così come viene percepita e vissuta, e quella della propria identità psicologica. **Lo psicotico, in pratica, non perde solo il contatto col mondo — perde il contatto con se stesso.**

La grande divisione: psicosi organiche vs. funzionali

Pensala come una cartografia del territorio. Le psicosi si dividono in due grandi continenti:

Psicosi organiche → causa organica nota, chiara, condivisa a livello scientifico. Il problema è fisico, biologico. Non c'entrano educazione, traumi o contesto sociale.

Psicosi funzionali → causa biologica ipotizzata ma non univoca. L'origine è multifattoriale: componente organica (es. neurotrasmettitori, genetica) + esperienze di vita + contesto sociale.

Il prof sottolinea che questa divisione non è più usata nel DSM attuale, ma rimane uno strumento efficace per capire il mondo delle psicosi.

Le psicosi organiche

Sindromi demenziali

Nelle demenze si assiste a un **progressivo indebolimento irreversibile di tutte le funzioni mentali**: area intellettiva, affettiva e volitiva. Il processo coinvolge il substrato organico.

L'esempio del pittore **William Utermöhlen** — diagnosticato con Alzheimer a 51 anni nel 1995 e morto nel 2007 — è particolarmente potente: i suoi autoritratti mostrano come identità e forma del sé si dissolvano progressivamente, fino a diventare un segno indistinguibile.

Tipi di demenza: - **Demenza senile** → legata all'invecchiamento e all'atrofia cerebrale - **Malattia di Alzheimer** → la più nota tra le demenze degenerative - **Demenze acquisite** → causate da agenti esterni (alcol, sifilide, ecc.)

La differenza chiave tra psicosi organiche e funzionali rispetto alle tre dimensioni **io—qui—adesso** (identità, spazio, tempo), come la spiega Minkowski (2004):

- **Demenza:** il soggetto *non sa più* dove si trova, chi è, che giorno è. I riferimenti spaziotemporali si sgretolano.
- **Schizofrenia:** il soggetto *sa* dove si trova e chi è, ma *non si sente* di appartenere a quel posto. C'è una distanza tra il sapere e il sentire.

Come dice la citazione del demente paralitico: risponde "qui" e batte il piede per terra. Lo schizofrenico invece dirà: "so dove mi trovo, ma non mi sento nel posto in cui mi trovo."

Epilessia

Il termine deriva dal greco e significa "attacco a sorpresa." Una crisi epilettica è un **malfunzionamento temporaneo delle cellule nervose** del cervello con scariche elettriche anormali.

Le epilessie si dividono in: - **Crisi generalizzate:** coinvolgono l'intero cervello - *Grande male:* tre fasi — tonica (contrazione muscolare), clonica (convulsioni), risolutiva (rilassamento + sonno). Accompagnata da: grido iniziale, morsicatura della lingua, rilascio involontario di urine. - *Piccolo male:* assenza di pochi secondi, senza convulsioni, senza consapevolezza. Il soggetto non reagisce agli stimoli esterni. - **Crisi parziali (o focali):** coinvolgono solo una parte del cervello. La manifestazione dipende dall'area coinvolta: allucinazioni uditive, movimenti involontari, parestesie periferiche, ecc.

Il prof sottolinea un punto importante per il lavoro educativo: **le assenze da piccolo male possono sembrare distrazione** in classe o in foyer. Un bambino "tra le nuvole" potrebbe essere in una crisi epilettica, non svegliato.

Psicosi da sostanze

Tutte le **sostanze psicoattive** — quelle che agiscono sul sistema mesolimbico (la via della dopamina) — hanno la capacità di produrre sintomi psicotici. Questo può avvenire sia durante l'uso eccessivo che durante l'astinenza.

Esempi: - **Delirium tremens** → psicosi alcolica acuta che si manifesta con l'*astinenza* dopo consumo prolungato. Tremore, allucinazioni, stati confusionali. Può essere letale. *Attenzione: chi beve molto non può smettere di colpo senza supervisione medica.* - **Sindrome di Korsakov** → psicosi alcolica cronica con **amnesia anterograda** (il paziente non riesce a fissare nuovi ricordi). Problema grave per la compliance terapeutica. - **Cannabis indoor** → principio attivo più alto, può produrre deliri e allucinazioni in chi ne fa uso eccessivo, specialmente nei cervelli in via di sviluppo.

Il DSM-5 mappa per ogni sostanza il tipo di disturbo psicotico prodotto (con intossicazione, con astinenza, o entrambi). *L'alcol è campione assoluto: produce sintomi psicotici sia con l'uso eccessivo che con l'astinenza.*

Le psicosi funzionali: sintomatologia comune

Tutte le psicosi condividono tre gruppi di sintomi:

1. **Sintomi positivi** (producono qualcosa che prima non c'era):
 - **Delirio** → alterazione del *contenuto* del pensiero. Convinzioni incrollabili, non riconducibili alla logica, false per gli altri.
 - **Allucinazione** → alterazione della *percezione*. Produzioni percettive senza corrispondente stimolo esterno (voci, visioni, sensazioni corporee).
 2. **Sintomi negativi** (sottraggono qualcosa):
 - Impoverimento ideo-affettivo, apatia, abulia (mancanza di volontà/iniziativa), ritiro sociale, anaffettività.
 3. **Disorganizzazione cognitiva** → il pensiero è confuso, frammentato, non coerente. Si manifesta nel linguaggio: deragliamenti, blocchi improvvisi, neologismi.
-

La schizofrenia

La **schizofrenia** è la **psicosi funzionale per eccellenza**. Eugen Bleuler coniò il **termine nel 1911** (dal greco: *schizein* = scissione + *phren* = mente), sostituendo il paradigma di Kraepelin che la chiamava "demenza precoce."

La schizofrenia non si manifesta nell'intelligenza, negli affetti o nella volontà — il paziente li ha tutti. Il problema è nella **capacità di tenerli insieme**. È come un'orchestra senza direttore: tutti i musicisti ci sono, ma il risultato è rumore. O come un libro con tutte le pagine mescolate: ci sono tutte, ma nell'ordine sbagliato.

Sindrome fondamentale

La **sindrome fondamentale** della schizofrenia comprende: dissociazione, autismo, delirio, depersonalizzazione, disturbi del comportamento. Aggiungiamo una nota sulle allucinazioni.

1. Dissociazione (o discordanza)

È il cuore della malattia. Si manifesta in tre ambiti:

a) Disturbi formali del pensiero (intelletto)

Il pensiero non riesce a mantenere coerenza e continuità. Si manifesta nel linguaggio: - **Disorganizzazione** → pensiero frammentato, caotico. Nei casi gravi: *neologismi* (parole inventate) ed *ecolalia* (il paziente ripete a eco le domande). - **Impoverimento** → discorso povero, lento, con poche informazioni. Risposte evasive, pause lunghe. Valutato sempre rispetto alla normalità personale precedente. - **Concretismo** → il soggetto rimane ancorato al concreto, non riesce ad accedere al simbolico e all'astratto. *Come una pianta che non riesce a crescere oltre il suolo*. - **Prolissità** → discorso lungo, senza filtri, con dettagli inutili. Il pensiero si perde e il discorso diventa "oscuro e poco concludente." - **Tangenzialità** → risposte "di traverso": rispondono alla forma della domanda ma non alla sostanza. *Esempio: "Come si chiama?" — "È importante nella vita avere un nome, tutte le persone ne hanno uno."* - **Deragliamento** → il discorso parte su un tema e poi salta improvvisamente a un altro senza continuità logica.

b) Alterazioni dell'affettività

Tre dimensioni (Pancheri & Cassano, 1999): - **Appiattimento affettivo** → riduzione della modulazione emotiva. Il paziente appare freddo, indifferente, anche davanti a eventi rilevanti. **Bleuler**: "in nessun caso però l'affettività è del tutto spenta." - **Discordanza** → la reazione emotiva non corrisponde alla situazione. Si ride di fronte a una notizia luttuosa. **Il prof ricorda che anche certi adolescenti vanno in discordanza emotiva non per prendere in giro, ma per eccessiva tensione interna.** - **Ambivalenza** → copresenza simultanea di emozioni opposte nello stesso momento.

c) Attività psicomotoria

Può essere: - *Ridotta* (la più frequente) → il paziente si ritira, sta a letto, smette di esplorare l'ambiente e di comunicare - *Aumentata* → agitazione psicomotoria, **crisi pantoclastica** (rompe e spacca oggetti senza finalità chiara) - *Alterata qualitativamente* → **manierismi** (comportamenti normali esasperati e teatrali), stereotipie

2. Autismo

L'autismo nella schizofrenia (concetto di Bleuler, distinto dal disturbo neurologico omonimo) descrive la **perdita del contatto vitale con la realtà**: il soggetto si ritira in un mondo interno, privato, impenetrabile. Il senso comune — quella base condivisa che permette la comunicazione — vacilla e viene sostituito da una logica propria.

Nei termini dei sintomi negativi moderni: ritiro sociale, disinteresse per il mondo esterno, linguaggio non orientato alla relazione.

3. Delirio

Il delirio è una **trasformazione della realtà** attraverso convinzioni false sostenute con insolita certezza. Tre caratteristiche (Sims, 2004): 1. Sostenuto con insolita convinzione 2. Non riconducibile alla logica 3. Falsità palese per gli altri

Contenuti ricorrenti nella schizofrenia: persecuzione, avvelenamento, influenzamento, gelosia, grandiosità.

Attenzione culturale: il contenuto del delirio dipende dal background culturale del paziente. Un sistema di credenze radicato in una cultura diversa dalla propria **non è necessariamente un delirio**. L'operatore sociale deve conoscere il contesto prima di valutare.

Il delirio può influenzare il comportamento in modo significativo (es. aggressività verso persone "invase dagli alieni").

4. Depersonalizzazione

Alterazione della coscienza dell'io che si esprime come **sensazione di estraneità o irrealtà** rispetto al mondo e a se stessi. Il paziente si vede "dall'esterno," come un automa o una marionetta.

Spesso associata alla **derealizzazione**: ci si sente distaccati dall'ambiente, come se ci fosse una membrana tra sé e il mondo. Il tempo diventa "congelato," cristallizzato, senza slancio progettuale.

5. Disturbi del comportamento

Tre aree principali:

- **Aggressività e suicidalità** → rischio suicidario 10-20 volte superiore alla popolazione generale. Punto cruciale: i pazienti schizofrenici non si suicidano durante lo scompenso, ma *quando recuperano* e si rendono conto della propria condizione. Il prof insiste: *"si ammazzano non perché la vita fa schifo, ma perché sanno che è bellissima e capiscono di non potervi più avere accesso."* Vigilanza massima alla dimissione, soprattutto nei giovani.
- **Alimentazione** → deliri di avvelenamento → evitamento selettivo di alimenti. Oppure ingestione indiscriminata di cibo (pseudo-bulimia) legata alla perdita del confine dentro/fuori.
- **Sessualità** → ripiegamento autoerotico. Ma soprattutto: angoscia identitaria sull'identità sessuale, spesso veicolata da voci allucinatorie.

6. Allucinazioni

Le allucinazioni uditive sono le più frequenti nella schizofrenia. Sono produzioni percettive senza stimolo esterno. Per il paziente, sono del tutto reali e indistinguibili da percezioni normali.

Il rapporto del paziente con le proprie allucinazioni è **molto vario**: - Alcuni le tacciono per paura di essere etichettati come "matti" - Alcuni le dissimulano perché le voci hanno un carattere positivo (consolatrici, guide) - Alcuni usano strategie per gestirle (es. musica a volume alto per coprirle) - **Alcuni ricevono voci perentorie che ordinano azioni pericolose** — qui la vigilanza è massima

Il prof sottolinea: non dare per scontato che ogni esperienza sensoriale insolita sia un'allucinazione. Il caso della pianta che si muoveva era un terremoto, non un'allucinazione. Ascolta sempre il paziente prima di concludere.

L'angoscia psicotica

L'angoscia nelle psicosi è qualitativamente diversa da quella delle nevrosi (angoscia di castrazione) e del disturbo borderline (angoscia di abbandono).

L'angoscia nella schizofrenia è l'angoscia di frammentazione: la paura di andare letteralmente a pezzi. I confini tra sé e l'altro sono labili — il mondo può invadere il soggetto, il soggetto può dissolversi nel mondo.

Il rapporto con l'altro in questo contesto è **fusionale**: lo psicotico non percepisce l'altro come separato ma come parte del proprio mondo. L'operatore che lavora con pazienti schizofrenici può sperimentare di essere "inglobato" nel suo universo.

Il decorso della schizofrenia

La schizofrenia ha un suo tempo, una sua storia naturale. **Esordisce tipicamente attorno ai 20 anni** (tarda adolescenza/prima età adulta), ragion per cui veniva chiamata "demenza precoce."

Fase premorbossa (infanzia → adolescenza)

Identificabile solo *retrospettivamente*. Caratteristiche tipiche: - Bambino isolato, solitario, poco sorridente - Difficoltà di familiarizzazione con i pari - Ansia sociale, diffidenza, sospettosità - Rendimento scolastico critico, comportamento a volte aggressivo - Emotività fredda, distaccata, scarsamente empatica

Queste caratteristiche non significano che quel bambino diventerà schizofrenico. Ma retrospettivamente le ritroviamo nell'anamnesi.

Vulnerabilità identificate (Stanghellini & Ballerini, 2005): - Difficoltà nelle relazioni interpersonali - Disturbi socio-emozionali - Disturbi del sé (pensiero, linguaggio, percezione) - Disturbi delle funzioni neuropsicologiche - Disturbi nel neurosviluppo

Fase prodromica

Le stesse caratteristiche del premorbossa si accentuano fino a interferire con la vita quotidiana. Il ritiro si accentua, il pensiero diventa "strano," compaiono interessi bizzarri, neologismi, frequentazione di gruppi marginali. L'ansia e l'angoscia aumentano.

Segni prodromici: ansia, irritabilità, depressione, apatia, disturbi cognitivi, fenomeni dissociativi, comportamenti bizzarri, sospettosità, ritiro sociale.

La fase prodromica dura mediamente 1-2 anni (Mc Gorry & Jackson, 1999).

Fase di stato (esordio psicotico)

Comparsa dei sintomi psicotici positivi (deliri, allucinazioni) con piena manifestazione della sindrome. È il momento dell'eventuale intervento psichiatrico.

Decorso e esiti

Il decorso può essere molto variabile: - **Schizofrenia di tipo 1** (Crow, 1980) → dominano i sintomi positivi; decorso potenzialmente reversibile; migliore risposta ai neurolettici - **Schizofrenia di tipo 2** → dominano i sintomi negativi;

andamento cronico con progressivo deterioramento cognitivo; risposta ridotta ai farmaci

Tre stadi di esito post-primo episodio (Schultze-Lutter, 2009): 1. **Remissione completa** entro 3 anni 2. **Ricaduta** con condizione a bassa sintomatologia intermittente 3. **Stato cronico** con sintomatologia persistente > 3 anni

Fattori prognostici favorevoli: diagnosi precoce, intervento farmacologico immediato, andamento acuto iniziale (paradossalmente migliore!), buon funzionamento premorbo, sesso femminile, esordio tardivo, rete sociale adeguata.

Fattori prognostici sfavorevoli: inizio precoce, familiarità, isolamento sociale, dominanza dei sintomi negativi, resistenza al trattamento.

Il ruolo dell'operatore sociale

Il prof insiste su diversi punti pratici per chi lavora in campo psichiatrico:

- **L'operatore vede quello che il clinico non vede:** il paziente che mette le cuffie a volume altissimo, che si chiude in camera, che smette di mangiare determinati cibi. Queste osservazioni vanno comunicate allo psichiatra.
 - **Non passivizzare il paziente:** anche un paziente psicotico rimane un soggetto con diritti e capacità di scelta. La diagnosi non annulla la persona.
 - **Non dare per scontato:** né che ogni comportamento strano sia sintomo, né che il sintomo noto sia sempre lo stesso.
 - **Vigilanza nel miglioramento:** il rischio suicidario è più alto *dopo* lo scompenso, quando il paziente recupera lucidità.
 - **Cultura e contesto:** prima di valutare un delirio, conoscere il sistema culturale del paziente.
-

Concetti chiave

Termine	Significato
Psicosi	

Termine	Significato
	Gruppo eterogeneo di disturbi con rapporto radicalmente alterato con la realtà
Psicosi organica	Causa biologica nota (demenza, epilessia, sostanze)
Psicosi funzionale	Causa multifattoriale, organica + psicosociale (es. schizofrenia)
Io–qui–adesso	Triade di Minkowski: identità, spazio, tempo — alterata in tutti i disturbi psicotici
Derealizzazione	Senso di distacco dall'ambiente, realtà percepita come estranea
Depersonalizzazione	Senso di distacco da se stessi, corpo percepito come estraneo
Sintomi positivi	Deliri e allucinazioni — producono qualcosa che prima non c'era
Sintomi negativi	Apatia, abulia, ritiro sociale, appiattimento affettivo
Dissociazione	Incapacità di tenere insieme le funzioni mentali
Delirio	Convinzione falsa, incrollabile, non riconducibile alla logica
Allucinazione	Percezione senza stimolo esterno corrispondente
Autismo (schizofrenico)	Perdita del contatto vitale con la realtà, ritiro nel mondo interno
Angoscia di frammentazione	Angoscia tipica della schizofrenia: paura di andare a pezzi
Sindrome di Korsakov	Psicosi alcolica cronica con amnesia anterograda
Delirium tremens	Psicosi alcolica acuta da astinenza

Termine	Significato
Premorbo	Periodo dell'infanzia con segni aspecifici, leggibile solo retrospettivamente
Prodromico	Fase con sintomi sempre più specifici che precedono l'esordio psicotico
Schizofrenia tipo 1	Sintomi positivi prevalenti, decorso potenzialmente reversibile
Schizofrenia tipo 2	Sintomi negativi prevalenti, decorso cronico con deterioramento
Neologismi	Parole inventate, segno di perdita della funzione sociale del linguaggio
Ecolalia	Rispondere ripetendo la domanda ricevuta
Tangenzialità	Risposta che sfiora il tema ma non risponde alla domanda
Deragliamento	Salto improvviso da un tema a un altro senza continuità logica
Crisi pantoclastica	Agitazione psicomotoria distruttiva senza finalità
Manierismi	Comportamenti normali portati all'esasperazione in modo teatrale

Collegamenti

- **Lezione sulla semiologia** (Cinzia Campello): orientamento nei tre assi io–qui–adesso — concetti ripresi e approfonditi qui
- **Modulo Elisa Milani**: disturbi da uso di sostanze, disturbo borderline (angoscia di abbandono vs. frammentazione)
- **Lezioni sulle nevrosi**: angoscia di castrazione come contrasto con l'angoscia psicotica

- **Disturbi di personalità:** cluster A (paranoide, schizoide, schizotipico) compatibili con il periodo premorbo

Temi aperti / da approfondire per i seminari: - Psicosi postparto e bufere deliranti acute - Farmacologia neurolettici e gestione dello scompenso

Domande di orientamento allo studio

1. Qual è la differenza tra psicosi organiche e psicosi funzionali, e perché questa distinzione è utile anche se il DSM attuale non la usa più?

Le **psicosi organiche** hanno una causa organica identificata e condivisa scientificamente (es. delirium da intossicazione alcolica, demenza, crisi epilettica).

Le **psicosi funzionali** (es. schizofrenia) hanno una componente biologica ipotizzata (neurotrasmettitori, genetica) ma non univoca — l'origine è multifattoriale. Il DSM attuale ha abbandonato la distinzione, ma resta utile come mappa orientativa: nel primo caso puoi cercare e trattare la causa organica; nel secondo, devi lavorare su più livelli (biologico, psicologico, sociale).

2. Cosa sono i sintomi positivi, negativi e di disorganizzazione nella schizofrenia? Fai almeno un esempio per categoria.

- **Positivi** (aggiunta di qualcosa che non dovrebbe esserci): allucinazioni, deliri, comportamento bizzarro
- **Negativi** (sottrazione di qualcosa che dovrebbe esserci): appiattimento affettivo, alogia (povertà del linguaggio), abulia, anedonia, ritiro sociale
- **Disorganizzazione** (perdita della coerenza): pensiero tangenziale, deragliamento, neologismi, ecolalia, manierismi

La distinzione è clinicamente rilevante perché i farmaci antipsicotici trattano meglio i sintomi positivi, mentre i negativi sono più resistenti e più legati al deterioramento funzionale a lungo termine.

3. Qual è la differenza tra delirio e allucinazione, e perché entrambi rappresentano un problema di rapporto con la realtà?

Il **delirio** è una convinzione falsa, non condivisibile e non modificabile dalla critica razionale. L'**allucinazione** è una percezione in assenza di stimolo esterno (si sente una voce che non esiste). In entrambi i casi il soggetto è convinto della propria esperienza — il delirio e l'allucinazione non sono vissuti come "sogni" ma come realtà. **È questo che li rende così destabilizzanti: non c'è accesso critico alla propria esperienza.**

4. Cos'è l'angoscia di frammentazione e in cosa si distingue dall'angoscia di castrazione (nevrotica) e dall'angoscia di abbandono (borderline)?

L'**angoscia di frammentazione** è l'angoscia primaria psicotica: il terrore che l'io si dissolva completamente — che non ci sia più un "io qui adesso" coerente. È la più arcaica e la più devastante. L'**angoscia di castrazione** è nevrotica: paura della punizione, della perdita di qualcosa di prezioso, ma il sé rimane intatto. L'**angoscia di abbandono** (borderline) è intermedia: il sé esiste ma è terrorizzato dall'assenza dell'altro che lo regola. **La distinzione orienta l'intervento: con uno psicotico non ha senso fare insight terapeutico — serve prima stabilizzare il contatto con la realtà.**

5. Descrivere il decorso della schizofrenia: fasi e fattori prognostici favorevoli.

Le fasi tipiche sono: (1) **premorbo** — ritiro progressivo, trascuratezza, comportamento eccentrico; (2) **prodromico** — sintomi sempre più specifici; (3) **esordio psicotico** — scompenso acuto; (4) **fase residua** — con possibile recupero parziale o cronicizzazione. I fattori prognostici **favorevoli** includono: esordio acuto (non insidioso), sesso femminile, età di esordio più tardiva, buon funzionamento premorbo, prevalenza di sintomi positivi (tipo 1), buon supporto sociale. La schizofrenia **tipo 2** (sintomi negativi prevalenti) ha un decorso più cronico e deteriorante.

6. Qual è il ruolo specifico dell'operatore sociale in psichiatria nei confronti di una persona con psicosi?

L'operatore sociale non fa diagnosi né terapia, ma ha un ruolo cruciale nell'**individuazione precoce** (riconoscere i segnali del periodo prodromico), nel **supporto al reinserimento** (abitativo, lavorativo, relazionale) e nel

mantenimento della rete. È spesso il professionista con il contatto più continuativo con la persona e la famiglia. Nella psicosi — dove i legami con la realtà sono fragili — la continuità, la coerenza e la prevedibilità del rapporto con l'operatore hanno di per sé un valore terapeutico. - Materiale clinico: video, testimonianze, dipinti dei pazienti